

Donc là, on a les soins oncologiques de support qui sont instaurés et normalement, c'est une phase qui va depuis le diagnostic de l'évolution, d'une évolution locale incurable ou d'une première métastase jusqu'au diagnostic de l'entrée en phase terminale. Alors, comment situer

son patient? Il faut savoir qu'en oncologie, il faut préciser la phase de la maladie. Donc, il y a des documents qu'il faut remplir avec des scores bien précis, bien définis.

En gériatrie, il y a d'autres scores qui sont dits biologiques. Dans ces scores-là, donc généralement, il y a un certain nombre de paramètres, notamment des dosages, qu'on va voir ultérieurement. Donc, sur ce schéma, un exemple d'un score, le Karnovski, qui est utilisé, l'indice de Karnovski, utilisé pour situer le patient.

Donc, c'est un score qui est utilisé pour définir l'état du patient. Donc, en fonction de l'état du patient et on a le score, on calcule et on aura une idée sur l'état du patient. Là encore, il y a la performance de statut de l'OMS.

C'est un deuxième score qui est utilisé aussi en fonction de l'évolution des activités que le patient ou que la personne en question peut effectuer. Et on mesure le score pour classer le patient. Donc, la démarche nutritionnelle, comme on vient de dire, elle doit s'inscrire.

Et ça, c'est un élément qui est très, très important à retenir, c'est qu'il faut qu'elle s'inscrive dans une véritable cohérence d'ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait d'abondance dans la prise en charge de ces patients-là, en dehors, bien sûr, de la démarche nutritionnelle. Et avant toute démarche, il faut rechercher tout d'abord et traiter les symptômes gênants.

C'est très, très important. Recherchez donc la douleur, la dyspnée, s'il y a des nausées, des vomissements, la constipation, une mycose buccale ou digestive, une dépression. Donc, c'est un état primordial qu'il ne faut pas négliger avant d'entamer la procédure nutritionnelle.

Il faut savoir aussi que ce sont des signes ou des symptômes qui peuvent être secondaires ou responsables d'une dénutrition ou d'une déshydratation. Donc, le projet nutritionnel doit être le fruit d'une réflexion multidisciplinaire dont le patient est le maître. La famille, bien sûr, doit intervenir et doit avoir un mot avant d'entamer toute procédure pour répondre, bien sûr, aux besoins du patient en question.

Bien sûr, si le patient refuse la prise en charge, dans le cas bien sûr de la phase palliative terminale, le refus du patient doit être respecté. Bien sûr, il faut insister sur les soins de bouche. C'est évident parce que comment avoir ces plaisirs quand on a la bouche sèche ou quand on a une mycose, quand on a des ulcérations ou des douleurs, c'est très important.

Alors, comment on va procéder? Donc, la prise en charge doit être régulière. Il faut prescrire des antifongiques, des antalgiques. Il faut insister sur la bonne hygiène de la bouche et il faut bien évidemment réévaluer la prise médicamenteuse.

C'est très important aussi. Il faut revoir la liste des médicaments que le patient prend parce que généralement, c'est stressant de prendre un certain nombre de médicaments avant le repas. Et surtout, s'il y a des médicaments avec un goût qui est amer, ça peut gêner l'alimentation du

patient juste après la prise médicamenteuse.

Donc, ce sont des éléments qui sont importants à connaître et à rechercher et qu'on doit rechercher d'ailleurs systématiquement avant d'entamer toute procédure ou d'instaurer toute procédure nutritionnelle. Donc voilà, c'est l'évaluation. On est toujours dans l'évaluation du patient.

Il faut avoir une idée sur le diagnostic principal, sur les antécédents du patient, les médications qu'on vient de voir maintenant. Il faut voir, mesurer le poids, le poids actuel par rapport au poids habituel du patient. Rechercher bien sûr l'appétit, l'état de la bouche.

Est-ce qu'il y a des problèmes de déglutition ou pas? Est-ce qu'il y a donc d'autres symptômes gênants? Ce qu'on vient de voir tout à l'heure, les maux et les vomissements, l'altération de goût, l'intolérance aux odeurs, s'il y a des ballonnements ou des gaz, les intolérances, les allergies. Il faut rechercher aussi les goûts et les préférences du patient. C'est très important parce que de toute manière, on va jouer sur ces données-là pour instaurer la bonne attitude.

Voir si le patient est autonome ou pas. On a vu tout à l'heure pour les différents scores qui nous permettront d'avoir ces données-là. Et bien sûr, un élément qui est très important, c'est le réseau familial et social.

Il faut voir le degré du support de l'entourage du patient, les limites financières, les équipements financiers nécessaires. Donc, il faut savoir que les différents symptômes qu'on a dit tout à l'heure, qu'il faudra chercher systématiquement. Il existe une certaine corrélation entre les différents symptômes.

On voit ici sur ce tableau que la douleur peut créer la nausée, qui va créer l'anorexie, qui serait responsable d'une perte de poids, de la cachexie. La constipation, elle donnera les nausées, les vomissements, la perte de poids et donc la cachexie. La stomatite ou la candidose buccale va être à l'origine d'une dysphagie.

Elle va donner une déshydratation, une perte de poids. Elle va donner la constipation. L'anxiété serait responsable d'une dyspnée.

Avec une notion de le patient va avaler de l'air, donc il y aura des érectations, des ballonnements, l'anorexie, puis la perte du poids, puis la cachexie. Donc, vous voyez, ce sont des symptômes qui sont liés, qui sont liés et qui seront à l'origine de la dénutrition et la déshydratation du patient. Donc, il faut les rechercher systématiquement et les traiter avant d'entamer la procédure nutritionnelle.

Alors, il faut savoir que ces signes-là sont présents chez 50% des patients cancéreux nouveaux. Donc, ces signes-là sont dus à l'évolution de la maladie, d'une part, donc essentiellement lorsqu'on parle du cancer, aux effets secondaires des opiacés, parce que ce sont des patients qui

sont en fin de vie, donc qui sont sous traitement antalgique à base d'opiacés. Ils sont dus à une perte de goût, à une altération de l'eau.

Donc, comment traiter? Il faut privilégier la voie orale, c'est très important. Il faut qu'il y ait une atmosphère relaxante, une position qui est adéquate, qui est confortable du patient. Il faut donner les aliments préférés qui simulent le plaisir de l'alimentation.

L'alimentation doit être fractionnée. Il faut insister sur les collations. L'horaire doit être souple et il faut utiliser les boissons nutritives faits maison et donner des suppléments nutritifs vitaminiques.

Alors, la dénutrition, quelles sont les causes de la dénutrition? On a vu tout à l'heure que cette dénutrition peut être liée à des symptômes préexistants qui sont liés à la maladie. Mais comment ça se fait? Il y a une dénutrition qui est dite d'origine exogène et la dénutrition d'origine endogène. Il faut savoir que les deux mécanismes interviennent dans la survenue de la dénutrition en général.

Donc, d'origine exogène, on déduit que c'est la diminution des apports et la dénutrition endogène liée à la pathologie, à la maladie en elle-même et à son évolution. Donc, la dénutrition d'origine exogène, c'est les patients qui sont anorexiques. Il faut savoir que l'anorexie est un symptôme qui est très fréquent en phase terminale d'une maladie grave, d'une maladie cancéreuse.

Elle peut être soit globale ou spécifique. Il y a une absence d'appétit, voire le dégoût de la nourriture et l'absence de sensation de faim. On a une notion de satiété précoce, sensation de satiété après quelques bouchées.

Donc, les obstacles à la nutrition orale, soit on a des troubles à la déglutition ou bien on a un obstacle sur les voies digestives. Alors, les autres facteurs qui limitent l'alimentation et l'hydratation, en dehors de l'atteinte buccale et les troubles psychiques sévères, les troubles de conscience et les nausées. Il y a aussi les traitements adjuvants, notamment la chimiothérapie et la radiothérapie.

Donc, l'origine endogène, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de perturbations métaboliques secondaires à une production anormale de médiateurs produits par l'hôte et par la tumeur. On a des cytokines, des hormones, des substances qui sont dites cachectisantes d'origine tumorale. Il y a aussi la notion de l'absence de l'adaptation métabolique au jeûne au cours de la cachectie cancéreuse avec un bilan azoté qui est fortement négatif, quel que soit le niveau des apports nutritionnels.

Les conséquences, bien sûr, de la dénutrition, c'est l'amour d'immortalité qui est très élevé avec la diminution de l'espérance de vie. C'est l'amaigrissement, l'amaigrissement avec le risque, bien sûr, de l'alimentation prolongée, avec toutes les complications qui peuvent survenir, notamment thrombo-embolique lié à l'alimentation prolongée. Mais aussi le risque de survenue des escars.

Aussi, donc, il y a la dépression de l'immunité, donc il y a un risque accru et important de survenue des infections qui sont elles-mêmes favorisées par l'immobilité et par l'alimentation. Alors la déshydratation, donc la déshydratation chez ces patients-là, elle est responsable d'état de confusion, d'agitation. Ceci se fait en réduisant la filtration glomérulaire.

Elle entraîne une insuffisance rénale avec un risque d'accumulation de certains médicaments toxiques, notamment les opioïdes. Bien sûr, la déshydratation serait à l'origine de la survenue d'un nombre important de troubles métaboliques ioniques qui peut avoir des conséquences sévères sur ce genre de patient. Donc, comment évaluer cliniquement? Tout d'abord, il faut commencer par l'interrogatoire, rechercher le diagnostic.

Il faut évaluer l'ancienneté et la sévérité de la perte de poids. Donc, la dénutrition est définie par une perte de poids de plus de 10% du poids habituel en moins de 6 mois ou de plus de 5% en 3 mois. Les causes sont multiples.

On les a vues tout à l'heure, les inversions alimentaires, l'anorexie, la dysphagie et puis les autres symptômes associés. Bien sûr, cette perte de poids aura des répercussions sur le patient, notamment un retentissement sur l'autonomie et l'image corporelle. Le patient accorde une importance très grande à cette notion de perte de poids.

L'examen clinique se base sur des mesures anthropométriques, notamment le poids, la taille, le calcul de l'indice de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré. Il est généralement inférieur à 21 kg par mètre carré chez l'homme et inférieur à 20 chez la femme lorsqu'il s'agit d'une dénutrition. Ces mesures anthropométriques se basent aussi sur la mesure des circonférences, notamment brachiale et surale.

Il faut rechercher, bien sûr, les signes de dénutrition, la maigreur, la myotrophie, les signes de déshydratation, examiner la cavité buccale à la recherche d'une cause locale aggravante. Pour l'évaluation clinique de la dénutrition, qui est une étape primordiale avant d'entamer la procédure et la démarche nutritionnelle, il y a également l'évaluation biologique. L'évaluation biologique se base sur le taux des marqueurs biochimiques, notamment l'albumine, la transthyrétine ou la préalbumine, la transferrine, la protéine vectrice du rétinol, la CRP.

Ces éléments-là, ces marqueurs biologiques, vont permettre un dépistage précoce de la dénutrition à un stade infraclinique. Ils vont permettre la classification de la dénutrition. Ils vont nous permettre aussi d'établir un index pronostique et ils vont être utilisés comme moyen de surveillance de l'efficacité de la rénutrition.

Bien sûr, il y a certaines limites du dosage des protéines sériques. D'une part, le fait que les protéines circulantes ne sont pas spécifiques de la dénutrition. D'autre part, la sensibilité ou leur sensibilité dépend de leur demi-vie.

On a les marqueurs qui ont une demi-vie qui est courte, notamment la préalbumine, la protéine

vectrice du rétinol. Ces paramètres-là sont sensibles à une diminution de l'apport de protéines énergétiques. Ce sont les paramètres les plus utilisés puisqu'ils ont une demi-vie qui est courte.

On va commencer par l'albumine. C'est le plus couramment utilisé. Il a une demi-vie qui est très longue, de 20 jours.

Synthétisé par le foie, le taux est de 35 à 50 grammes par litre. C'est un marqueur qui est inadapté pour la détection des variations nutritionnelles aiguës. Ceci est lié à sa demi-vie qui est très longue.

C'est un paramètre qu'on trouve en baisse dans les syndromes inflammatoires aigus et chroniques. La préalbumine est synthétisée aussi par le foie, mais elle a une demi-vie plasmatique de 2 jours. La réserve est faible.

Les valeurs normales chez l'adulte sont estimées entre 250 et 350 mg par litre. Ce paramètre chute lors des jeûnes, lors de la grossesse, dans les insuffisances hépatiques, dans les syndromes inflammatoires, dans l'hyperthyroïdie et le syndrome néphrotique. Lorsque le taux est entre 100 et 200 mg par litre, on parle d'une dénutrition modérée.

Lorsqu'il est inférieur à 100 mg par litre, on parle d'une dénutrition sévère. Ce paramètre donne une indication qui est rapide des variations en apport protéique ou énergétique. C'est un paramètre qui est utile comme marqueur lors de la rénutrition.

Cela permet une détection précoce vu la demi-vie qui est très courte. La protéine vectrice du rétinol est synthétisée par le foie. Elle a une demi-vie un peu plus longue que la préalbumine.

Elle est de 12 heures. On le trouve au niveau du plasma. La protéine vectrice du rétinol est liée à la préalbumine.

C'est un marqueur qui a un rôle physiologique. C'est le transport du rétinol du foie aux divers tissus ciblés. Il y a d'autres marqueurs qui peuvent être utilisés.

Il y a des marqueurs biologiques qui sont utilisés dans cette évaluation, notamment la transferrine qui reflète les réserves en fer de l'organisme. Le taux normal est de 2 à 2,5 grammes par litre. Il augmente lors des syndromes inflammatoires.

Il a une demi-vie de 8 à 10 jours. Il y a également la CRP, la protéine c-réactive. Il y a l'orozomicoïde qui est une protéine d'inflammation qui traduit l'ancienneté du processus inflammatoire avec un seuil pathologique de 1,2 grammes par litre.

Et il y a le tocéric de l'infocyte lorsqu'il est inférieur à 1 000 bien qu'il est peu sensible pour témoigner d'une dénutrition profonde. On a vu les différents marqueurs biologiques qu'on utilise dans l'évaluation de la dénutrition chez les patients en soins palliatifs. On a vu les caractéristiques des différents marqueurs en fonction de leur demi-vie et leur utilité, bien sûr.

Là, on a les différents index nutritionnels, notamment l'index de Busby, le nutritionnel risque index, le NRI, qu'on voit ici sur l'écran. Le NRI est égal à l'albumine plasmatique en grammes par litre fois 1,519 plus le poids actuel sur le plan habituel en kilos fois 41,7. Vous voyez ici, en fonction des valeurs, on peut statifier la dénutrition du patient non dénutrié à la dénutrition modérée à la dénutrition sévère en fonction de l'index de Busby.

Bien sûr, il y a d'autres moyens à part l'index de Busby. Il y a le PINI, le pronostic inflammatory and nutritionnel index. Vous avez ici l'équation.

On ne va pas retenir cette équation, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs moyens d'évaluer en se basant sur ces index-là et qui permettront de statifier nos patients en fonction du score. Concernant les besoins énergétiques, il faut retenir que les besoins énergétiques moyens sont estimés à entre 30 et 35 kcal par kilo par jour et que les besoins protéiques sont estimés en moyenne pour un patient qui est dénutrié à un gramme par kilo par jour. Lorsqu'il s'agit d'un patient à préchirurgie lourde ou infection sévère, il est augmenté ou les besoins sont plus importants.

C'est 1,2 jusqu'à 1,5 gramme par kilo par jour. Là, c'est pour montrer l'évaluation de l'état nutritionnel et la prise en charge de la dénutrition chez le patient cancéreux adulte. On commence par l'évaluation nutritionnelle avec les différents paramètres qu'on a cités tout à l'heure, notamment le poids, la taille, l'alimentation, les troubles digestifs, l'état des principes du patient, tous les éléments qu'on a cités tout à l'heure.

Après, on mesure l'indice de masse corporelle et bien sûr, la perte de poids. Après cette évaluation, si on a un risque de dénutrition, si l'alimentation orale est possible, on fait des supplémentations. Alimentation qui est enrichie par matière grasse, donc avec tous les moyens qu'on dispose.

Les compléments nutritionnels oraux aussi. Si l'alimentation orale est impossible, mais que le tube digestif est fonctionnel, on entame la nutrition entérale et on va voir tout à l'heure les modalités de l'alimentation entérale. Et puis, bien sûr, si l'alimentation orale est impossible et que le tube digestif n'est pas fonctionnel, c'est l'indication à une nutrition parentérale.

Et on va voir tout à l'heure ces indications. Alors, un petit mot sur l'hydratation en soins palliatifs. Il faut chercher, bien sûr, des arguments qui sont en faveur de l'hydratation artificielle chez ces patients-là.

Voir s'il y a de la confusion, de l'agitation, s'il y a un risque d'accumulation, bien sûr, des médicaments. Notamment les opioïdes. Ça, on vient de le voir tout à l'heure.

Ça va aggraver, bien sûr, l'insuffisance rénale et accélérer la fin de vie. Il faut, bien sûr, maintenir les fonctions cognitives du patient. Mais, bien sûr, de manière raisonnable, pas en fin de vie.

Il faut accompagner les patients. On ne doit pas être délétère non plus. Il ne faut pas tomber dans la surcharge.

Il faut, bien sûr, que les apports hydriques soient adaptés au terrain, aux patients et à sa pathologie. Donc, là, on revient pour récapituler tout ce qu'on vient de dire. Dans la démarche nutritionnelle, bien sûr, il faut commencer par les soins de bouche et traiter, bien sûr, l'anorexie.

C'est très important. Bien sûr, il y a les traitements médicamenteux qui se basent sur des produits particuliers, notamment le médroxyprogestérone acétate et le prednisone. Donc, ce sont des médicaments utilisés dans le traitement de l'anorexie.

Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure et toujours dans la récapitulation, il faut avoir une souplesse dans les horaires. Il faut prendre le temps de manger. Il faut avoir une position confortable, boire suffisamment.

Plutôt boire en dehors des repas. Prendre les médicaments avec des jus, avec des fruits en fin de repas. Respecter les goûts des patients, leurs habitudes, la diversification, les collations.

Il faut encourager le patient à grignoter, varier les goûts, les épices, etc. Et enrichir les aliments en protéines. Bien sûr, il faut soigner la présentation des repas.

Il faut traiter tous les symptômes, notamment les nausées et les vomissements par proposer des repas froids afin de diminuer les odeurs, pour diminuer le risque de survenir des nausées au moment des repas. Il faut avoir une ambiance qui est conviviale. Et c'est de là où apparaît l'importance du soutien et du support de l'entourage et de la famille du patient.

Et bien sûr, faire des supplémentations orales en fonction des besoins. Et ceci en matière d'oligo-éléments et de vitamines. Donc, on a vu tout à l'heure concernant les indications des différents types de nutrition.

On a parlé de la nutrition orale lorsqu'elle est possible chez le patient. Donc, il faut la privilégier, bien sûr. Lorsque le malade ne peut pas s'alimenter oralement, mais il a un tube digestif qui est fonctionnel, on a dit que la nutrition entérale sera de mise.

Et lorsque le tube digestif n'est pas fonctionnel et que le patient ne peut pas s'alimenter oralement, alors à ce moment-là, c'est une indication à la nutrition parentérale. Donc, concernant l'alimentation entérale, elle a ses indications, c'est une technique d'assistance nutritive de choix en cas de dénutrition sévère ou d'échec ou d'insuffisance de la supplémentation nutritionnelle orale chez un patient aux fonctions digestives normales ou peu altérées. Donc, c'est important de connaître ces indications de la nutrition entérale.

Donc, la nutrition entérale peut être utilisée transitoirement lorsqu'il y a des vomissements ou autres signes gênants, ou bien elle est définitive lorsqu'on a une atteinte de la filière digestive



haute, notamment lorsqu'il s'agit de tumeurs, des voies digestives hautes ou de la sphère ORL. Donc, elle peut être transitoire ou définitive. Donc, la nutrition artificielle ne peut se justifier que si le risque mortel découle de la dénutrition et non de la progression de la tumeur.

En règle générale, la mise en route de nutrition artificielle ne se justifie pas si l'espérance de vie du patient est inférieure à trois mois et l'atteinte fonctionnelle permanente sévère. Lorsqu'on a une atteinte fonctionnelle permanente sévère, c'est-à-dire en se basant bien sûr sur les indices de Karnovski, lorsqu'il est inférieur à 50%, ou le performance statut lorsqu'il est supérieur à deux. Donc, les méthodes pour cette alimentation entérale, soit par la mise en place d'une sonde nasogastrique.

Généralement, il faut l'éviter au maximum vu son caractère qui est douloureux et inesthétique. Mais bien sûr, quand on n'a pas le choix, il faut bien s'assurer que la dose est bien mise en place. Toujours dans les méthodes, donc à part la sonde nasogastrique, il y a aussi la technique de gastrostomie percutane endoscopique.

Donc, ça c'est pour les patients qu'on veut alimenter d'une durée prévisible qui est supérieure à un mois. Ou bien par une sonde nasogégenale ou par gégenostomie. Et généralement, c'est préconisé chez les patients qui sont atteints d'une gastroparesie ou chez les patients qui sont à haut risque d'inhalation.

Donc, ça, c'était pour les méthodes, les différentes méthodes d'alimentation entérale. Bien sûr, si on pose une sonde nasogastrique, il faut bien sûr contrôler et fixer la sonde. Donc, la fixation est obligatoire et les radiologiques aussi, il faut la confirmer radiologiquement.

Ce sont des sondes qui sont radio opaques, donc la radio standard permettra de localiser donc le trajet de la sonde qui est mise en place. La position doit être entérale pré-pylorique. Bien sûr, pour les produits qu'on va passer par ces sondes là, donc le choix des produits dépendra des besoins énergétiques et protéiques du patient, mais aussi du volume souhaité, calculé.

Donc, on l'a vu tout à l'heure pour les apports et les besoins énergétiques et protéiques chez les patients. Bien sûr, chez les patients qui sont dénutris, on va augmenter les apports bien sûr au-dessus des besoins. Tenir compte des apports énergétiques eurosponnés associés, bien sûr, il faut tout calculer et on peut apporter jusqu'à 40 à 45 kilocalories par kilo par jour et 2 grammes de protéines par kilo par jour, à condition que les apports aient été augmentés progressivement.

Bien sûr, dans l'alimentation, il faut toujours débiter prudemment afin de vérifier la tolérance et éviter l'échec. Donc, lorsqu'on a une dénutrition qui est modérée, on peut augmenter les apports sur 4 jours, 25 %, puis 50 %, puis 75 %, puis 100 % de l'apport énergétique souhaité. Donc, on parle progressivement.

Lorsqu'on a une dénutrition qui est sévère, l'augmentation des apports doit être plus lente, sur 7 à 10 jours en général. Donc, pour le mode d'administration, ça dépend de l'état du patient. Est-ce

qu'il est conscient ? Est-ce qu'il est inconscient ? On peut utiliser un régulateur du débit qui va nous permettre d'optimiser la tolérance de la nutrition entérale et il est préférable, bien sûr, à l'administration par bolus.

Donc là, c'est différent comme technique parce que l'alimentation entérale administrée par bolus. Donc, ce sont des bolus calculés en ML qu'on va introduire par la sonde nasogastrique, mais avec des bolus qui sont séparés à des heures fixes. Alors que pour le régulateur du débit, lorsqu'on en dispose, ça permet d'optimiser la tolérance, ça permet d'avoir un débit qui est continu et ça nous permet, bien sûr, d'ajuster le débit en fonction de la tolérance du patient, on peut augmenter comme on peut baisser le débit.

Bien sûr, lorsqu'on entame l'alimentation entérale, il faut avoir donc une surveillance. C'est une surveillance quotidienne pour voir la tolérance, est-ce qu'il y a un résidu gastrique, est-ce qu'il y a des vomissements. Généralement, chez ces patients-là, on surveille deux fois par semaine le poids après avoir entamé l'alimentation, deux fois par semaine, on mesure le poids du patient pour voir si on est efficace ou pas.

Et bien sûr, chaque semaine, il faut faire un bilan biologique avec une albuminémie pour voir l'état nutritionnel de ces patients-là. Donc sur ce tableau-là, j'ai mis les principales complications de la nutrition entérale et comment les prévenir. Ce sont des éléments qu'on a mis à titre informatif pour que vous sachiez un peu comment la procédure se déroule généralement et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a des complications qui surviennent au cours de cette alimentation.

Toujours pareil sur ce sur ce tableau. Les données qui ont été présentées sur les tableaux, c'est des données à ne pas retenir. Voilà, on a vu la nutrition orale, on a parlé de la nutrition entérale.

Alors maintenant, un petit mot sur l'alimentation parentérale. L'indication de la nutrition parentérale, c'est lorsque l'alimentation orale et l'alimentation entérale sont impossibles ou bien ils sont inefficaces. Lorsqu'on a des syndromes occlusifs qui sont chroniques par une carcinose péritoneale, par exemple, lorsqu'on a des malabsorptions.

Généralement, on peut la proposer, cette alimentation parentérale, mais jamais à la phase terminale parce que ça ne sert absolument à rien lorsqu'on est à la phase terminale. Généralement, l'administration se fait par voie veineuse. Elle reste une alternative des procédures précédentes.

Bien sûr, lorsque il y a des contre-indications aux procédures précédentes. Son utilisation le plus souvent est à l'origine de complications. C'est pour ça qu'il faut peser le bénéfice-risque avant de l'entamer.

Pour conclure notre cours, les messages clés, c'est que la démarche nutritionnelle doit s'inscrire dans une démarche globale, jamais de démarche nutritionnelle avec abondance des autres

éléments de prise en charge. Donc, avant d'entamer la procédure, il faut passer par la stratification de la maladie. C'est très important parce que cette démarche-là n'est pas indiquée dans toutes les phases d'évolution de la maladie, notamment dans la maladie cancéreuse.

Elle commence tout d'abord par une évaluation du patient. Dans l'évaluation du patient, en passant par l'interrogatoire, à la recherche, bien sûr, des antécédents du patient, à la recherche de son traitement habituel de ses terrains, la recherche des signes et des symptômes existants. Et bien sûr, une évaluation qui est clinique aussi, donc avec la mesure du poids, de la taille, de l'indice de masse corporelle.

Aussi, une évaluation biologique de l'état nutritionnel du patient, qui est très importante. On a vu tout à l'heure les différents marqueurs utilisés et leur utilité en fonction de leur demi-vie. On a vu aussi qu'il y a plusieurs méthodes et techniques d'alimentation et d'hydratation de ces patients-là en soins palliatifs et qu'il faut choisir la meilleure méthode et la meilleure technique, la technique la plus adaptée au patient, à son état et à son terrain.

Bien sûr, on a dit aussi que c'est une démarche qui nécessite un accord préalable avec le patient et avec, bien sûr, la famille du patient, puisque c'est cette famille-là qui va permettre un soutien et un support lors de la démarche. Et bien sûr, qu'il faut privilégier la nutrition et l'hydratation orale parce que, finalement, c'est la normale, donc c'est physiologique, c'est la plus proche de la physiologie humaine, donc avec moins d'effets secondaires et moins de risques. Je vous remercie.